



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
KOMITE MEDIK
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

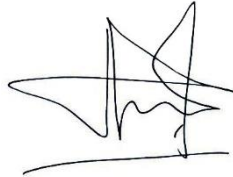
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 218/I-PDM/DIR/IV/2026

Tentang
Pedoman Kerja Komite Medik

Disusun oleh :
Ketua Komite Medik



(dr. Arief Heru Wicaksono, SpAn)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M.Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Kerja Komite Medik dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Kerja Komite Medik ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada contributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Kerja Komite Medik ini, mutu pelayanan tenaga medis Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Resti Lestantini, M.Kes

TIM PENYUSUN
PEDOMAN KERJA KOMITE MEDIK

1. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
2. drg. Endi Wira, MMRS
3. dr. Yeni Octavia
4. dr. Rino Rachmatullah
5. dr. Nur Rohman
6. dr. Yuniar Ardy Santoso
7. dr. Amanda Firmandani
8. dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD
9. dr. Edi Wibowo, Sp.U
10. drg. Bhakti Prasetyo D., Sp. Ort.
11. dr. Ardhi Bustami, Sp. PD
12. dr. Heriyatmo, Sp. PD
13. dr. Zoraida Dwi Wahyuni, Sp. PD
14. dr. Dicky Faturrachman, Sp. A
15. dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A
16. dr. Fiona Paramitha, Sp.A
17. dr. Nurhadhi Sutanto, Sp. M
18. dr. Titok Hariyanto, Sp. M
19. dr. Ira Setya Waty, Sp. JP
20. dr. Miryanti Cahyaningtias, Sp. JP
21. dr. Andy. Sp.P
22. dr. Catur Elvi Purnamawati, Sp. P
23. dr. Agung Setyawan Sp.Rad
24. dr. Rumbiyo Yudho, Sp. Rad.
25. dr. Puti Fajri Lestari, Sp. OG
26. dr. Dewi Maharani, Sp. S
27. dr. Akhmad Syahrir, Sp.N
28. dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N
29. dr. Denny Setiawan, Sp. An-TI
30. dr. Antonius Setiadi, Sp. B
31. dr. Rossy Zaki Abdillah, Sp.B
32. dr. Iwan Donosepoetro, SP. B FINACS
33. dr. Sigit Wahyu Jatmiko, Sp. BP-RE
34. Dr.dr. M. Kuntadi Syamsul Hidayat, Sp. OT, M.Kes.,MMR
35. dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT
36. dr. Arianto Prabowo, Sp. OT
37. dr. Ari Putriani, Sp. PK
38. dr. Aida Musyarrofah, Sp. OG
39. dr. Humaira Rahma, Sp. OG
40. dr. Meyrna, Sp. THT-KL
41. dr. Nimim Putri Zahara, Sp.THT-KL
42. dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ
43. dr. Pradana Nurhadi, Sp. U
44. dr. Dwi Nurwulan Pravitasari, Sp. KK
45. dr. Adya Sp.DVE
46. dr. Eko Nugroho, Sp. KFR
47. dr. Virginia, Sp.KFR
48. Ns. Fadhila Ayu Setyani, S.Kep

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

KATA PENGANTAR.....3

TIM PENYUSUN ii

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA1

LAMPIRAN.....1

BAB I.....1

PELAYANAN KOMITE MEDIK.....1

BAB II.....2

ORGANISASI TIM KOMITE MEDIK2

BAB IV7

KREDENSIAL STAF MEDIS7

BAB V12

MUTU PROFESI STAF MEDIS12

BAB VI16

ETIK DAN DISIPLIN.....16

BAB VII19

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN MSBL.....19

BAB VII22

PENUTUP22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Komite Medik



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 218/I-PDM/DIR/IV/2026**

TENTANG

PEDOMAN KERJA KOMITE MEDIK

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. Bahwa profesionalisme staf medis perlu ditingkatkan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien dengan penyelenggaraan komite medik;
- b. Bahwa untuk mendapat pengakuan tentang kualitas pelayanan yang dilakukan, rumah sakit harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Komite Medik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PEDOMAN KERJA KOMITE MEDIK.**



BAB I
PELAYANAN KOMITE MEDIK

Pasal 1

- (1) Komite Medik dibentuk untuk melakukan koordinasi semua kegiatan komite medik secara terstruktur dengan melibatkan staf RS Prima Husada Malang
- (2) Segala yang berhubungan dengan rapat Komite Medik diatur oleh sekretaris Komite Medik termasuk persiapan dan hasil rapat.
- (3) Komite Medik membina hubungan kerja dengan Komite/Tim lain di RS yang berhubungan dengan staf medis.

BAB II
ORGANISASI KOMITE MEDIK

Pasal 2

- (1) Struktur organisasi komite medik terdiri dari :
 - a. Ketua komite medik
 - b. Sekretaris komite medik
 - c. Sub Komite Kredensial
 - d. Sub Komite Profesi
 - e. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi
- (2) Terdapat proses seleksi staf medis untuk memastikan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi staf klinis sesuai dengan kebutuhan pasien
- (3) Proses seleksi dilaksanakan seragam
- (4) Setiap dokter yang memberikan pelayanan di rumah sakit, wajib menandatangani perjanjian
- (5) Anggota staf klinis baru dievaluasi pada saat mulai bekerja, sesuai dengan tanggung jawabnya
- (6) Evaluasi staf medis dilakukan dan didokumentasikan secara berkala setiap 6 bulan sekali
- (7) Bertanggung jawab mendukung komunikasi yang efektif antar tenaga profesional
- (8) Bertanggung jawab Menyusun kebijakan, pedoman prosedur serta protokol, tata hubungan kerja, alur klinis dan dokumen yang mengatur layanan klinis
- (9) Bertanggungjawab menyusun kode etik profesi komite medik
- (10) Bertanggung jawab memantau pelayanan pasien lainnya

BAB III
KEGIATAN DAN TATA LAKSANA KOMITE MEDIK

Pasal 3

- (1) Terdapat pelaksanaan verifikasi dari sumber utama terhadap kredensial terkait pendidikan, izin/sertifikat dan kredensial lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan atau organisasi profesional yang diakui
- (2) Terdapat pelaksanaan kredensial tambahan dari sumber yang mengeluarkan kredensial apabila staf medis meminta kewenangan klinis cangguh atau subspecialisasi



- (3) Pengangkatan staf medis dibuat berdasarkan kebijakan rumah sakit dan konsisten dengan populasi pasien rumah sakit, misi, dan pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien
- (4) Pengangkatan tidak dilakukan sampai setidaknya izin/surat tanda registrasi sudah diverifikasi dari sumber primer, dan anggota staf medis kemudian melakukan pelayanan perawatan pasien di bawah supervisi sampai semua kredensial yang disyaratkan undang-undang dan peraturan sudah diverifikasi dari sumber asli
- (5) Untuk staf medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri, dilakukan metode supervisi, frekuensi supervisi, dan supervisor yang ditunjuk didokumentasikan di arsip kredensial individu tersebut

Pasal 4

- (1) Direktur menetapkan kewenangan klinis setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medis termasuk kewenangan tambahan
- (2) Pemberian kewenangan klinis berdasarkan rekomendasi kewenangan klinis dari Komite Medis
- (3) pelaksanaan pemberian kewenangan tambahan setelah melakukan verifikasi dari sumber yang mengeluarkan kredensial
- (4) Surat Penugasan klinis dan Rincian Kewenangan klinis anggota staf medis dalam bentuk tercetak atau
- (5) elektronik (softcopy) atau media lain tersedia di semua unit pelayanan (contoh, kamar operasi, unit darurat, nurse station) dimana anggota staf medis tersebut memberikan pelayanan
- (6) Setiap anggota staf medis hanya memberikan pelayanan spesifik yang ditentukan oleh rumah sakit

Pasal 5

- (1) Terdapat penilaian kinerja untuk evaluasi mutu praktik profesional berkelanjutan, etik dan disiplin staf medis
- (2) Monitoring dan evaluasi mutu praktik profesional berkelanjutan, etik dan disiplin staf medis untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien
- (3) Data dan informasi hasil pelayanan klinis dari staf klinis direview, jika ada, dilakukan benchmarking dengan pihak eksternal rumah sakit
- (4) Data dan informasi berasal dari proses monitoring dikaji sekurang kurangnya setiap 12 bulan oleh kepala unit layanan, ketua kelompok staf medis, sub komite mutu, manajer pelayanan medis dan hasilnya, kesimpulannya dan tindakan yang dilakukan didokumentasikan di dalam file kredensial staf medis atau dokumen lain yang relevan
- (5) Bila ada temuan yang berdampak terhadap pemberian kewenangan staf klinis, ada proses untuk tindak lanjut terhadap temuan dan tindakan tersebut didokumentasi dalam file staf medis dan disampaikan ke tempat staf medis memberikan pelayanan
- (6) Berdasarkan monitoring dan evaluasi berkelanjutan kredensial anggota staf medis yang dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun ditetapkan kewenangan klinisnya tetap, bertambah atau berkurang



-
- (7) Pemberian kewenangan tambahan didasarkan pada kredensial yang telah diverifikasi dari sumber aslinya sesuai peraturan perundang-undangan
 - (8) Dokumen setiap anggota staf medis selalu diperbaharui secara periodik satu tahun sekali

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Komite medik melakukan pencatatan dan pelaporan kepada pimpinan rumah sakit.

Pasal 7

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 07 April 2026
Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M.Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN KOMITE MEDIK

PEDOMAN KOMITE MEDIK

BAB I

PELAYANAN KOMITE MEDIK

Rumah sakit diakui merupakan institusi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi (*high risk*), terlebih dalam kondisi lingkungan regional dan global yang sangat dinamis perubahannya. Salah satu pilar pelayanan medis adalah (*Clinical Governance*), dengan unsur staf medis yang dominan. Kepala rumah sakit bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.

Keberadaan staf medis dalam rumah sakit merupakan suatu keniscayaan karena kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh kinerja para staf medis di rumah sakit tersebut. Yang lebih penting lagi kinerja staf medis akan sangat mempengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk itu rumah sakit perlu menyelenggarakan tata kelola klinis (*Clinical Governance*) yang baik untuk melindungi pasien. Komite medik menangani berbagai hal yang bersifat pengelolaan, seperti misalnya panitia rekam medis, panitia pencegahan dan pengendalian infeksi, dan panitia farmasi dan terapi, hal ini akan merencanakan fungsi keprofesian dengan fungsi pengelolaan rumah sakit. Oleh karenanya dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini, komite medik ditegaskan hanya menangani masalah keprofesian saja dan bukan menangani pengelolaan rumah sakit yang seharusnya dilakukan Kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit dapat membentuk berbagai panitia/pokja dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Panitia/pokja tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala rumah sakit.

Rumah sakit harus menerapkan model komite medik yang menjamin tata kelola klinis (*Clinical Governance*) untuk melindungi pasien. Dalam model tersebut setiap staf medis dikendalikan dengan mengatur kewenangan klinisnya (*Clinical Privilege*) untuk melakukan pelayanan medis, hanya staf medis yang memenuhi syarat-syarat kompetensi dan perilaku tertentu sajalah yang boleh melakukan pelayanan medis. Pengaturan kewenangan klinis tersebut dilakukan dengan mekanisme pemberian izin untuk melakukan pelayanan medis (*entering to the profession*), kewajiban memenuhi syarat-syarat kompetensi dan perilaku tertentu untuk mempertahankan kewenangan klinis tersebut (*maintaining professionalism*), dan pencabutan izin (*expelling from the profession*). Untuk melindungi keselamatan pasien, komite medik di rumah sakit harus memiliki ketiga mekanisme diatas. Fungsi lain di luar ketiga fungsi di atas dilaksanakan oleh Kepala rumah sakit.

Untuk menjamin agar komite medik berfungsi dengan baik, organisasi dan tata laksana komite medik dituangkan dalam peraturan internal staf medis (*Medical Staff By Laws*) yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan ini. Pada prinsipnya peraturan internal staf medis (*Medical Staff By Laws*) merupakan dasar normatif bagi setiap staf medis agar tercipta budaya profesi yang baik dan akuntabel.

BAB II

ORGANISASI TIM KOMITE MEDIK

A. Organisasi Komite medik

Pada dasarnya komite medik bukan merupakan kumpulan atau himpunan kelompok staf medis fungsional/departemen klinik sebuah rumah sakit. Para staf medis yang tergabung dalam kelompok staf medis fungsional/departemen klinik di organisasi oleh Kepala rumah sakit. Komite medik dibentuk oleh Kepala rumah sakit dan bertanggung jawab kepada Kepala rumah sakit. Organisasi komite medik sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua komite medik ditetapkan oleh Kepala rumah sakit. Sekretaris dan anggota diusulkan oleh ketua komite medik dan ditetapkan oleh Kepala rumah sakit. Dalam hal wakil ketua komite medik diperlukan maka wakil ketua diusulkan oleh ketua komite medik dan ditetapkan oleh Kepala rumah sakit.

Jumlah personalia komite medis yang efektif berkisar sekitar lima sampai sembilan orang termasuk ketua dan sekretaris. Namun demikian, untuk rumah sakit dengan jumlah staf medis terbatas dapat menyesuaikan dengan situasi sejauh tugas dan fungsi komite medis tetap terlaksana. Walaupun rumah sakit memiliki staf medis yang terbatas jumlahnya, budaya profesionalisme yang akuntabel harus tetap ditegakkan melalui penyelenggaraan tata kelola klinis yang baik. Pasien harus tetap terlindungi tanpa melihat besar kecilnya jumlah staf medis. Personalia tersebut dipilih dari staf medis yang memiliki reputasi baik dalam profesinya yang meliputi kompetensi, sikap, dan hubungan interpersonal yang baik.

Ketua subkomite kredensial, subkomite mutu profesi, dan subkomite etika dan disiplin profesi diusulkan oleh ketua komite medik dan ditetapkan oleh Kepala rumah sakit. Di lain pihak, dalam pelaksanaan pelayanan medis sehari-hari di rumah sakit, Kepala rumah sakit dapat mengelompokkan staf medis berdasarkan disiplin/spesialisasi, peminatan, atau dengan cara lain berdasarkan kebutuhan rumah sakit sesuai peraturan internal rumah sakit (*corporate bylaws*).

Wakil ketua, sekretaris, dan ketua-ketua subkomite direkomendasikan oleh ketua komite medik dan ditetapkan oleh Kepala rumah sakit dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit. Selain itu, Kepala rumah sakit mengangkat beberapa staf medis di rumah sakit tersebut untuk menjadi anggota pengurus komite medik dan anggota subkomite-subkomite di bawah komite medik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, komite medik senantiasa melibatkan mitra bestari untuk mengambil putusan profesional. Rumah sakit bersama komite medik menyiapkan daftar mitra bestari yang meliputi berbagai macam bidang ilmu kedokteran sesuai kebutuhannya. Mitra bestari tersebut akan dibutuhkan oleh setiap subkomite dalam menjalankan tugasnya.

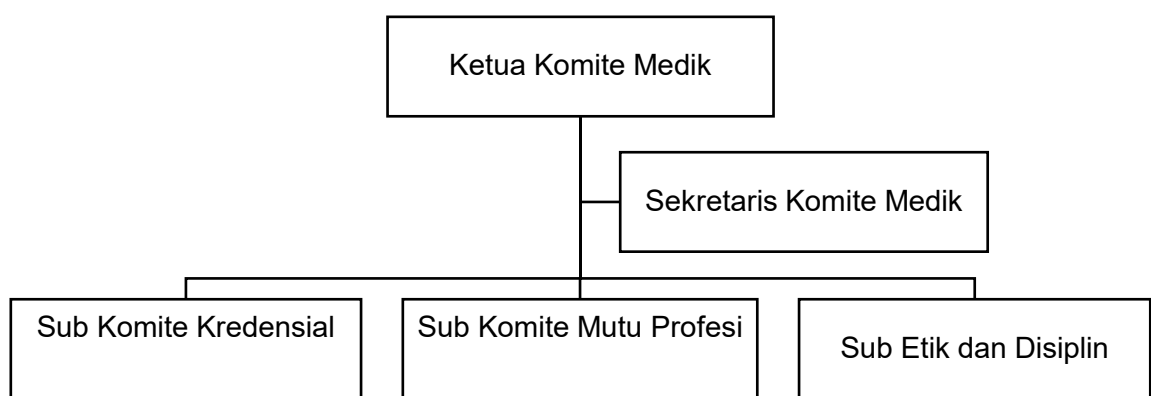
Mekanisme pengambilan keputusan di bidang keprofesian dalam setiap kegiatan komite medis dilaksanakan secara sehat dengan memperhatikan asas-asas kolegialitas. Peraturan internal staf rumah sakit (*Medical Staff By Laws*) akan menetapkan lebih rinci tentang mekanisme tersebut.

Komite medik bertugas menegakkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit. Komite medik bertugas melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit, memelihara kompetensi dan etika para staf medis, dan mengambil tindakan disiplin bagi staf medis. Tugas Komite medik diantaranya :

- a. Rekomendasi pemberian izin untuk melakukan pelayanan medis (*entering to the profession*), dilakukan melalui subkomite kredensial;

- b. Memelihara kompetensi dan perilaku para staf medis yang telah memperoleh izin (maintaining professionalism), dilakukan oleh subkomite mutu profesi melalui audit medis dan pengembangan profesi berkelanjutan (*continuing professional development*);
- c. Rekomendasi penangguhan kewenangan klinis tertentu hingga pencabutan izin melakukan pelayanan medis (*expelling from the profession*), dilakukan melalui subkomite etika dan disiplin profesi.
- d. Dengan demikian, tugas-tugas lain diluar tugas-tugas diatas yang terkait dengan pelayanan medis bukanlah menjadi tugas komite medik, tetapi menjadi tugas Kepala rumah sakit dalam mengelola rumah sakit.

B. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Komite Medik

Ketua komite medik bertanggung jawab kepada Kepala rumah sakit. Direktur rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan segala sumber daya agar komite medik dapat berfungsi dengan baik untuk menyelenggarakan profesionalisme staf medis sesuai dengan ketentuan. Komite medik memberikan laporan tahunan dan laporan berkala tentang kegiatan keprofesian yang dilakukannya kepada Direktur rumah sakit. Dengan demikian lingkup hubungan antara Direktur rumah sakit dengan komite medik adalah dalam hal-hal yang menyangkut profesionalisme staf medis saja. Hal-hal yang terkait dengan pengelolaan rumah sakit dan sumber dayanya dilakukan sepenuhnya oleh Direktur Rumah Sakit.

Untuk mewujudkan tata kelola klinis (*Clinical Governance*) yang baik Direktur rumah sakit bekerjasama dalam hal pengaturan kewenangan melakukan tindakan medik di rumah sakit. Kerjasama tersebut dalam bentuk rekomendasi pemberian kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medis dan rekomendasi pencabutannya oleh komite medik.

Untuk mewujudkan pelayanan klinis yang baik, efektif, professional, dan aman bagi pasien, sering terdapat kegiatan pelayanan yang terkait erat dengan masalah keprofesian. Direktur rumah sakit bekerjasama dengan komite medik untuk menyusun pengaturan layanan medis (*medical staff rules and regulations*) agar pelayanan yang profesional terjamin mulai saat pasien masuk rumah sakit hingga keluar dari rumah sakit.

A. KETUA KOMITE MEDIK

1. Klasifikasi:
Dokter Spesialis
2. Uraian tugas :
 - a. Membuat rencana program kerja Komite Medis
 - b. Melakukan Pengorganisasian program kerja Komite Medik
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi, Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
 - d. Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mewakili pendapat, kebijakan, laporan, kebutuhan dan keluhan staf medik
 - e. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas semua risalah rapat yang diselenggarakan Komite Medik
 - f. Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada dan kepanitiaan lainnya
3. Tanggung jawab :
Bertanggung jawab pada Direktur RS Prima Husada
4. Wewenang
 - a. Menunjuk dan menetapkan wakil ketua, sekretaris dan ketua-ketua Sub Komite Medis
 - b. Menentukan agenda setiap rapat Komite Medik

B. SEKRETARIS

1. Klasifikasi:
Perawat atau Bidan dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun
2. Uraian tugas :
 - a. Membuat dan mendokumentasikan surat keluar Komite Medik
 - b. Mengarsip surat masuk dan dokumen-dokumen Komite Medik
 - c. Membantu dalam membuat Program Kerja Komite Medik
 - d. Membantu dalam membuat Pedoman Kredensial, Pedoman Mutu Profesi, Pedoman Etika dan Profesi Komite Medik
 - e. Membantu pembuatan SPO terkait kegiatan program Komite Medik
 - f. Membuat pemberitahuan undangan-undangan kepada semua anggota Komite medik dan seluruh Dokter untuk menghadiri rapat dan morning report
 - g. Mempersiapkan materi dan kelengkapan notulensi, absensi, konsumsi, ruangan rapat morning report dan komite medik
 - h. Membantu pembuatan laporan bulanan dan tahunan Program Kerja Komite Medik
2. Tanggung jawab :
 - a. Bertanggung jawab pada ketua komite medik
 - b. Bertanggung jawab pada Direktur RS Prima Husada
3. Wewenang
 - a. Menunjuk dan menetapkan wakil ketua, sekretaris dan ketua-ketua Sub Komite Medis
 - b. Menentukan agenda setiap rapat Komite Medik

C. SUB KOMITE KREDENSIAL

1. Klasifikasi:
Dokter Spesialis
2. Uraian Tugas :
 - a. Menyusun dan mengkompilasi daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku.

- b. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengkajian:
 - 2) kompetensi
 - 3) kesehatan fisik dan mental
 - 4) perilaku
 - 5) etika profesi
 - c. Mengevaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan.
 - d. Melakukan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis.
 - e. Menilai dan memutuskan kewenangan klinis yang adekuat.
 - f. Melaporkan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik.
 - g. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik.
 - h. Merekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
2. Tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab pada ketua komite medik
 - b. Bertanggung jawab pada Direktur RS Prima Husada
3. Wewenang :
- a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis
 - b. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis
 - c. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu
 - d. Memberikan rekomendasi perubahan / modifikasi rincian kewenangan klinis

C. SUB KOMITE MUTU PROFESI

1. Klasifikasi:
Dokter Spesialis
2. Uraian Tugas :
- a. Melaksanakan audit medis.
 - b. Merekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis.
 - c. Merekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut.
 - d. Merekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
3. Tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab pada ketua komite medik
 - b. Bertanggung jawab pada Direktur RS Prima Husada
4. Wewenang :
- a. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis
 - b. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan

E. SUB KOMITE ETIK DAN DISIPLIN

1. Klasifikasi:
Dokter Spesialis
2. Uraian Tugas :
- a. Pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran.
 - b. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
 - c. Merekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit.
 - d. Pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.
2. Tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab pada ketua komite medik
 - b. Bertanggung jawab pada Direktur RS Prima Husada

3. Wewenang :

- a. Memberikan rekomendasi pendampingan
- b. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin

BAB III

KREDENSIAL STAF MEDIS

A. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit kredibel.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendapatkan dan memastikan staf medis yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan di rumah sakit
- b. Tersusunnya jenis-jenis kewenangan klinis (*clinical privilege*) bagi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit sesuai dengan cabang ilmu kedokteran/kedokteran gigi yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran/Kedokteran Gigi Indonesia
- c. Dasar bagi Kepala rumah sakit untuk menerbitkan penugasan klinis (*Clinical Appointment*) bagi setiap staf medis untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit
- d. Terjaganya reputasi dan kredibilitas para staf medis dan institusi rumah sakit di hadapan pasien, penyandang dana, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) rumah sakit lainnya.

B. Konsep

1. Konsep Dasar Kredensial

Salah satu upaya rumah sakit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan pasiennya adalah dengan menjaga standar dan kompetensi para staf medis yang akan berhadapan langsung dengan para pasien di rumah sakit. Upaya ini dilakukan dengan cara mengatur agar setiap pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasiennya dilakukan oleh staf medis yang benar-benar kompeten. Kompetensi ini meliputi dua aspek, kompetensi profesi medis yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional, serta kompetensi fisik dan mental.

Walaupun seorang staf medis telah mendapatkan *brevet* spesialisasi dari kolegium ilmu kedokteran yang bersangkutan, namun rumah sakit wajib melakukan verifikasi kembali keabsahan bukti kompetensi seseorang dan menetapkan kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medis dalam lingkup spesialisasi tersebut, hal ini dikenal dengan istilah *credentialing*.

Proses *credentialing* ini dilakukan dengan dua alasan utama. Alasan pertama, banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi setelah seseorang mendapatkan sertifikat kompetensi dari kolegium. Perkembangan ilmu di bidang kedokteran untuk suatu pelayanan medis tertentu sangat pesat, sehingga kompetensi yang diperoleh saat menerima sertifikat kompetensi bisa kedaluarsa, bahkan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak aman bagi pasien. Selain itu, lingkup suatu cabang ilmu kedokteran tertentu senantiasa berkembang dari waktu ke waktu

sehingga suatu tindakan yang semula tidak diajarkan pada penerima brevet pada periode tertentu, dapat saja belakangan diajarkan pada periode selanjutnya, bahkan dianggap merupakan suatu kemampuan yang standar. Hal ini mengakibatkan bahwa sekelompok staf medis yang menyandang sertifikat kompetensi tertentu dapat saja memiliki lingkup kompetensi yang berbeda-beda. Alasan kedua, keadaan kesehatan seseorang dapat saja menurun akibat penyakit tertentu atau bertambahnya usia sehingga mengurangi keamanan pelayanan medis yang dilakukannya. Kompetensi fisik dan mental dinilai melalui uji kelayakan kesehatan baik fisik maupun mental. Tindakan verifikasi kompetensi profesi medis tersebut oleh rumah sakit disebut sebagai mekanisme *credentialing*, dan hal ini dilakukan demi keselamatan pasien. Tindakan verifikasi kompetensi ini juga dilakukan pada profesi lain untuk keamanan kliennya. Misalnya kompetensi profesi penerbang (*pilot*) yang senantiasa diperiksa secara teratur dalam periode tertentu oleh perusahaan penerbangan.

Setelah seorang staf medis dinyatakan kompeten melalui suatu proses kredensial, rumah sakit menerbitkan suatu izin bagi yang bersangkutan untuk melakukan serangkaian pelayanan medis tertentu di rumah sakit tersebut, hal ini dikenal sebagai kewenangan klinis (*Clinical Privilege*). Tanpa adanya kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) tersebut seorang staf medis tidak diperkenankan untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut. Luasnya lingkup kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) seseorang dokter spesialis/dokter gigi spesialis dapat saja berbeda dengan koleganya dalam spesialisasi yang sama, tergantung pada ketetapan komite medik tentang kompetensi untuk melakukan tiap pelayanan medis oleh yang bersangkutan berdasarkan hasil proses kredensial. Dalam hal pelayanan medis seorang staf medis membahayakan pasien maka kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) seorang staf medis dapat saja dicabut sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan pelayanan medis tertentu di lingkungan rumah sakit tersebut. Pencabutan kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) tersebut dilakukan melalui prosedur tertentu yang melibatkan komite medik.

Kewajiban rumah sakit untuk menetapkan kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) tersebut telah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang perumahnya bahwa setiap rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan *hospital bylaws*, yang dalam penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan bahwa setiap rumah sakit wajib melaksanakan tata kelola klinis yang baik (*good Clinical Governance*). Hal ini harus dirumuskan oleh setiap rumah sakit dalam peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff bylaw*) antara lain diatur kewenangan klinis (*clinical privilege*).

Kelemahan rumah sakit dalam menjalankan fungsi kredensial akan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit dalam hal terjadi kecelakaan pelayanan medis. Setiap rumah sakit wajib melindungi pasiennya dari segala pelayanan medis yang dilakukan oleh setiap staf medis di rumah sakit tersebut, hal ini dikenal sebagai *the duty of due care*. Tanggung jawab rumah sakit tersebut berlaku tidak hanya terhadap tindakan yang dilakukan oleh staf medis pegawai rumah sakit saja, tetapi juga setiap staf medis yang bukan berstatus pegawai (staf medis tamu). Rumah sakit wajib mengetahui dan menjaga keamanan setiap pelayanan medis yang dilakukan dalam lingkungannya demi keselamatan semua pasien yang dilayaninya sebagai bagian dari *the duty of due care*.

Untuk memenuhi kebutuhan staf medis di rumah sakit dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit memerlukan penambahan staf medis. Kepala rumah sakit menentukan kebutuhan dan penambahan staf medis. Komite medik dapat diminta oleh Kepala rumah sakit untuk melakukan kajian kompetensi calon staf medis.

2. Mekanisme Kredensial

- a. Mekanisme kredensial dan rekredensial di rumah sakit adalah tanggung jawab komite medik yang dilaksanakan oleh subkomite kredensial. Proses kredensial tersebut dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif, sesuai dengan prosedur, dan terdokumentasi.
- b. Dalam proses kredensial, subkomite kredensial melakukan serangkaian kegiatan termasuk menyusun tim mitra bestari, dan melakukan penilaian kompetensi seorang staf medis yang meminta kewenangan klinis tertentu. Selain itu subkomite kredensial juga menyiapkan berbagai instrument kredensial yang disahkan Kepala rumah sakit. Instrumen tersebut paling sedikit meliputi kebijakan rumah sakit tentang kredensial dan kewenangan klinis, pedoman penilaian kompetensi klinis, formulir yang diperlukan.
- c. Pada akhir proses kredensial, komite medik menerbitkan rekomendasi kepada Kepala rumah sakit tentang lingkup kewenangan klinis seorang staf medis.

C. Keanggotaan

Subkomite kredensial di rumah sakit terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis (*Clinical Appointment*) di rumah sakit tersebut dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Pengorganisasian subkomite kredensial sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada ketua komite medik.

D. Mekanisme Kredensial Dan Pemberian Kewenangan Klinis Bagi Staf Medis di rumah sakit

Kepala rumah sakit menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur bagi staf medis untuk memperoleh kewenangan klinis dengan berpedoman pada peraturan internal staf medis (*Medical Staff By Laws*). Selain itu Kepala rumah sakit bertanggung jawab atas tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara. Untuk melaksanakan kredensial dibutuhkan beberapa instrumen, antara lain daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap spesialisasi medis, daftar mitra bestari yang merepresentasikan tiap spesialisasi medis, dan buku putih (*white paper*) untuk setiap pelayanan medis. Setiap rumah sakit mengembangkan instrumen tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Secara garis besar tahapan pemberian kewenangan klinis yang harus diatur lebih lanjut oleh rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Staf medis mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada Kepala Rumah Sakit dengan mengisi formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung.
2. Berkas permohonan staf medis yang telah lengkap disampaikan oleh Kepala rumah sakit kepada komite medik.
3. Kajian terhadap formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah diisi oleh pemohon.
4. Dalam melakukan kajian subkomite kredensial dapat membentuk panel atau panitia ad-hoc dengan melibatkan mitra bestari dari disiplin yang sesuai dengan kewenangan klinis yang diminta berdasarkan buku putih (*white paper*).
5. Subkomite kredensial melakukan seleksi terhadap anggota panel atau panitia ad-hoc dengan mempertimbangkan reputasi, adanya konflik kepentingan, bidang disiplin, dan kompetensi yang bersangkutan.
6. Pengkajian oleh subkomite kredensial meliputi elemen:

-
- a. Kompetensi :
Berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu
 - 1) Kognitif
 - 2) Afektif
 - 3) Psikomotor
 - b. Kompetensi fisik
 - c. Kompetensi mental/perilaku
 - d. Perilaku etis (*ethical standing*)
7. Kewenangan klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan mencakup praktik.
 8. Daftar rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*) diperoleh dengan cara:
 - a. Menyusun daftar kewenangan klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap Kelompok Staf Medis.
 - b. Mengkaji kewenangan klinis bagi Pemohon dengan menggunakan daftar rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*).
 - c. Mengkaji ulang daftar rincian kewenangan klinis bagi staf medis dilakukan secara periodik.
 9. Rekomendasi pemberian kewenangan klinis dilakukan oleh komite medik berdasarkan masukan dari subkomite kredensial.
 10. Subkomite kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis (*clinical appointment*), dengan rekomendasi berupa:
 - a. Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan
 - b. Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah
 - c. Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi
 - d. Kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu
 - e. Kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi
 - f. Kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri.
 11. Bagi staf medis yang ingin memulihkan kewenangan klinis yang dikurangi atau menambah kewenangan klinis yang dimiliki dapat mengajukan permohonan kepada komite medik melalui Kepala rumah sakit. Selanjutnya, komite medik menyelenggarakan pembinaan profesi antara lain melalui mekanisme pendampingan (*proctoring*).
 12. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi kewenangan klinis:
 - a. Pendidikan:
 - 1) Lulus dari sekolah kedokteran yang terakreditasi, atau dari sekolah kedokteran luar negeri dan sudah diregistrasi
 - 2) Menyelesaikan program pendidikan konsultan.
 - b. Perizinan (*lisensi*):
 - 1) Memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi
 - 2) Memiliki izin praktek dari dinas kesehatan setempat yang masih berlaku.

c. Kegiatan penjagaan mutu profesi:

- 1) Menjadi anggota organisasi yang melakukan penilaian kompetensi bagi anggotanya
- 2) Berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis.

d. Kualifikasi personal:

- 1) Riwayat disiplin dan etik profesi
- 2) Keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui
- 3) Keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat penggunaan obat terlarang dan alkohol, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien
- 4) Riwayat keterlibatan dalam tindakan kekerasan
- 5) Memiliki asuransi proteksi profesi (*professional indemnity insurance*)

e. Pengalaman dibidang keprofesian:

- 1) Riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi;
- 2) Riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi.

Berakhirnya kewenangan klinis. Kewenangan klinis akan berakhir bila surat penugasan klinis (*Clinical Appointment*) habis masa berlakunya atau dicabut oleh Kepala rumah sakit. Surat penugasan klinis untuk setiap staf medis memiliki masa berlaku untuk periode tertentu, misalnya dua tahun. Pada akhir masa berlakunya surat penugasan tersebut rumah sakit harus melakukan rekredensial terhadap staf medis yang bersangkutan. Proses rekredensial ini lebih sederhana dibandingkan dengan proses kredensial awal sebagaimana diuraikan di atas karena rumah sakit telah memiliki informasi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut.

Pencabutan, perubahan/modifikasi, dan pemberian kembali kewenangan klinis. Pertimbangan pencabutan kewenangan klinis tertentu oleh Kepala rumah sakit didasarkan pada kinerja profesi di lapangan, misalnya staf medis yang bersangkutan terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental. Selain itu, pencabutan kewenangan klinis juga dapat dilakukan bila terjadi kecelakaan medis yang diduga karena inkompetensi atau karena tindakan disiplin dari komite medik. Namun demikian, kewenangan klinis yang dicabut tersebut dapat diberikan kembali bila staf medis tersebut dianggap telah pulih kompetensinya. Dalam hal kewenangan klinis tertentu seorang staf medis diakhiri, komite medik akan meminta subkomite mutu profesi untuk melakukan berbagai upaya pembinaan agar kompetensi yang bersangkutan pulih kembali. Komite medik dapat merekomendasikan kepada Kepala rumah sakit pemberian kembali kewenangan klinis tertentu setelah melalui proses pembinaan.

Pada dasarnya kredensial tetap ditujukan untuk menjaga keselamatan pasien, sambil tetap membina kompetensi seluruh staf medis di rumah sakit tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa komite medik dan peraturan internal staf medis memegang peranan penting dalam proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis untuk setiap staf medis.

BAB IV

MUTU PROFESI STAF MEDIS

A. Konsep

Kualitas pelayanan medis yang diberikan oleh staf medis sangat ditentukan oleh semua aspek kompetensi staf medis dalam melakukan penatalaksanaan asuhan medis (*medical care management*). Mutu suatu penatalaksanaan asuhan medis tergantung pada upaya staf medis memelihara kompetensi seoptimal mungkin. Untuk mempertahankan mutu dilakukan upaya pemantauan dan pengendalian mutu profesi melalui :

1. Memantau kualitas, misalnya *morning report*, kasus sulit, ronde ruangan, kasus kematian (*death case*), audit medis, *journal reading*;
2. Tindak lanjut terhadap temuan kualitas, misalnya pelatihan singkat (*short course*), aktivitas pendidikan berkelanjutan, pendidikan kewenangan tambahan.

B. Keanggotaan.

Subkomite mutu profesi di rumah sakit terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis (*Clinical Appointment*) di rumah sakit tersebut dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Pengorganisasian subkomite mutu profesi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada ketua komite medik.

Subkomite mutu profesi berperan dalam menjaga mutu profesi medis dengan tujuan:

1. Memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf medis yang bermutu, kompeten, etis, dan professional
2. Memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh kesempatan memelihara kompetensi (*maintaining competence*) dan kewenangan klinis (*Clinical Privilege*)
3. Mencegah terjadinya kejadian yang tak diharapkan (*Medical Mishaps*)
4. Memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf medis melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan (*on-going professional practice evaluation*), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (*focused professional practice evaluation*).

C. Mekanisme Kerja.

Kepala rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur seluruh mekanisme kerja subkomite mutu profesi berdasarkan masukan komite medis. Selain itu Kepala rumah sakit bertanggungjawab atas tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara.

1. Audit Medis

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perumahasakitan, pelaksanaan audit medis dilaksanakan sebagai implementasi fungsi manajemen klinis dalam rangka penerapan tata kelola klinis yang baik di rumah sakit. Audit medis tidak digunakan untuk mencari ada atau tidaknya kesalahan seorang staf medis dalam satu kasus. Dalam hal terdapat laporan kejadian dengan dugaan kelalaian seorang

staf medis, mekanisme yang digunakan adalah mekanisme disiplin profesi, bukannya mekanisme audit medis.

Audit medis dilakukan dengan mengedepankan respek terhadap semua staf medis (*no blaming culture*) dengan cara tidak menyebutkan nama (*no naming*), tidak mempersalahkan (*no blaming*), dan tidak mempermalukan (*no shaming*).

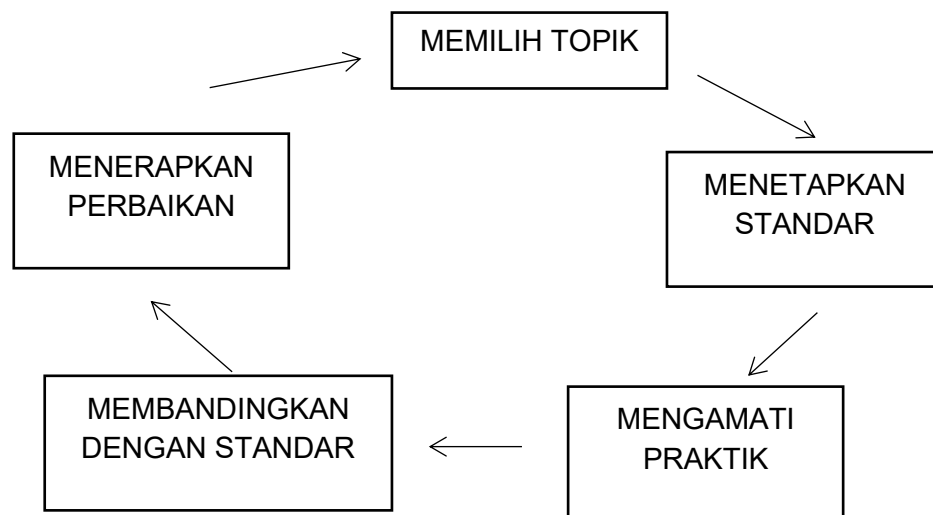
Audit medis yang dilakukan oleh rumah sakit adalah kegiatan evaluasi profesi secara sistemik yang melibatkan mitra bestari (*peer group*) yang terdiri dari kegiatan *peer-review*, *surveillance* dan *assessment* terhadap pelayanan medis di rumah sakit.

Dalam pengertian audit medis tersebut di atas, rumah sakit, komite medik atau masing-masing kelompok staf medis dapat menyelenggarakan menyelenggarakan evaluasi kinerja profesi yang terfokus (*focused professional practice evaluation*).

Secara umum, pelaksanaan audit medis harus dapat memenuhi 4 (empat) peran penting, yaitu :

- a. Sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masing-masing staf medis pemberi pelayanan di rumah sakit
- b. Sebagai dasar untuk pemberian kewenangan klinis (*clinical privilege*) sesuai kompetensi yang dimiliki
- c. Sebagai dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan kewenangan klinis (*clinical privilege*)
- d. Sebagai dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis seorang staf medis.

Audit medis dapat pula diselenggarakan dengan melakukan evaluasi berkesinambungan (*on-going professional practice evaluation*), baik secara perorangan maupun kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dapat merupakan kegiatan yang berbentuk siklus sebagai upaya perbaikan yang terus menerus sebagaimana tercantum di bawah ini:



Berdasarkan siklus di atas maka langkah-langkah pelaksanaan audit medis dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan topik yang akan dilakukan audit
Tahap pertama dari audit medis adalah pemilihan topik yang akan dilakukan audit. Pemilihan topik tersebut bisa berupa penanggulangan

penyakit tertentu di rumah sakit (misalnya : *typhus abdominalis*), penggunaan obat tertentu (misalnya: penggunaan antibiotik), tentang prosedur atau tindakan tertentu, tentang infeksi nosokomial di rumah sakit, tentang kematian karena penyakit tertentu, dan lain-lain. Pemilihan topik ini sangat penting, dalam memilih topik agar memperhatikan jumlah kasus atau epidemiologi penyakit yang ada di rumah sakit dan adanya keinginan untuk melakukan perbaikan. Sebagai contoh di rumah sakit kasus *typhus abdominalis* cukup banyak dengan angka kematian cukup tinggi. Hal ini tentunya menjadi masalah dan ingin dilakukan perbaikan. Contoh lainnya : angka seksio sesaria yang cukup tinggi di rumah sakit yang melebihi dari angka nasional. Untuk mengetahui penyebabnya sehingga dapat dilakukan perbaikan maka perlu dilakukan audit terhadap seksio sesaria tersebut. Pemilihan dan penetapan topik atau masalah yang ingin dilakukan audit dipilih berdasarkan kesepakatan komite medik dan kelompok staf medis.

2) Penetapan standar dan kriteria

Setelah topik dipilih maka perlu ditentukan kriteria atau standar profesi yang jelas, obyektif dan rinci terkait dengan topik tersebut. Misalnya topik yang dipilih *typhus abdominalis* maka perlu ditetapkan prosedur pemeriksaan, diagnosis dan pengobatan *typhus abdominalis*. Penetapan standar dan prosedur ini oleh mitra bestari (*peer group*) dan/atau dengan ikatan profesi setempat. Ada dua level standar dan kriteria yaitu *must do* yang merupakan absolut minimum kriteria dan *should do* yang merupakan tambahan kriteria yang merupakan hasil penelitian yang berbasis bukti.

3) Penetapan jumlah kasus/sampel yang akan diaudit

Dalam mengambil, sampel bisa dengan menggunakan metode pengambilan sampel tetapi bisa juga dengan cara sederhana yaitu menetapkan kasus *typhus abdominalis* yang akan diaudit dalam kurun waktu tertentu, misalnya dari bulan Januari sampai Maret. Misalnya selama 3 bulan tersebut ada 200 kasus maka 200 kasus tersebut yang akan dilakukan audit.

4) Membandingkan standar/kriteria dengan pelaksanaan pelayanan. Subkomite mutu profesi atau tim pelaksana audit medis mempelajari rekam medis untuk mengetahui apakah kriteria atau standar dan prosedur yang telah ditetapkan tadi telah dilaksanakan atau telah dicapai dalam masalah atau kasus-kasus yang dipelajari. Data tentang kasus-kasus yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dipisahkan dan dikumpulkan untuk di analisis. Misalnya dari 200 kasus ada 20 kasus yang tidak memenuhi kriteria atau standar maka 20 kasus tersebut agar dipisahkan dan dikumpulkan.

5) Melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria

Subkomite mutu profesi atau tim pelaksana audit medis menyerahkan ke 20 kasus tersebut pada mitra bestari (*peer group*) untuk dinilai lebih lanjut. Kasus-kasus tersebut di analisis dan didiskusikan apa kemungkinan penyebabnya dan mengapa terjadi ketidaksesuaian dengan standar. Hasilnya: bisa jadi terdapat (misalnya) 15 kasus yang penyimpangannya terhadap standar adalah "*acceptable*" karena penyulit atau komplikasi yang tak diduga sebelumnya (*unforeseen*). Kelompok ini disebut deviasi (yang *acceptable*). Sisanya yang 5 kasus adalah deviasi yang *unacceptable*, dan hal ini dikatakan sebagai "*defisiensi*". Untuk melakukan analisis kasus tersebut apabila diperlukan dapat mengundang konsultan tamu atau pakar dari luar, yang biasanya dari rumah sakit Pendidikan.

6) Menerapkan perbaikan

Mitra bestari (*peer group*) melakukan tindakan korektif terhadap kelima kasus yang defisiensi tersebut secara kolegial, dan menghindari

“*blaming culture*”. Hal ini dilakukan dengan membuat rekomendasi upaya perbaikannya, cara-cara pencegahan dan penanggulangan, mengadakan program pendidikan dan latihan, penyusunan dan perbaikan prosedur yang ada dan lain sebagainya.

7) Rencana reaudit

Mempelajari lagi topik yang sama di waktu kemudian, misalnya setelah 6 (enam) bulan kemudian. Tujuan reaudit dilaksanakan adalah untuk mengetahui apakah sudah ada upaya perbaikan. Hal ini bukan berarti topik audit adalah sama terus menerus, audit yang dilakukan 6 (enam) bulan kemudian ini lebih untuk melihat upaya perbaikan. Namun sambil melihat upaya perbaikan ini, Subkomite mutu profesi atau tim pelaksana audit dan mitra bestari (*peer group*) dapat memilih topik yang lain.

2. Merekomendasikan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Staf Medis.

- a. Subkomite mutu profesi menentukan pertemuan-pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok staf medis dengan pengaturan-pengaturan waktu yang disesuaikan.
- b. Pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus tersebut antara lain meliputi kasus kematian (*death case*), kasus sulit, maupun kasus langka.
- c. Setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi.
- d. Notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumen/arsip dari subkomite mutu profesi.
- e. Subkomite mutu profesi bersama-sama dengan kelompok staf medis menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh subkomite mutu profesi yang melibatkan staf medis rumah sakit sebagai narasumber dan peserta aktif.
- f. Setiap kelompok staf medis wajib menentukan minimal satu kegiatan ilmiah yang akan dilaksanakan dengan subkomite mutu profesi pertahun.
- g. Subkomite mutu profesi bersama dengan bagian pendidikan & penelitian rumah sakit memfasilitasi kegiatan tersebut dan dengan mengusahakan aturan angka kredit dari ikatan profesi.
- h. Subkomite mutu profesi menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing staf medis setiap tahun dan tidak mengurangi hari cuti tahunannya.
- i. Subkomite mutu profesi memberikan persetujuan terhadap permintaan staf medis sebagai asupan kepada direksi.

3. Memfasilitasi Proses Pendampingan (*Proctoring*) bagi Staf Medis yang Membutuhkan.

- a. Subkomite mutu profesi menentukan nama staf medis yang akan mendampingi staf medis yang sedang mengalami sanksi disiplin/mendapatkan pengurangan *clinical privilege*.
- b. Komite medik berkoordinasi dengan Kepala rumah sakit untuk memfasilitasi semua sumber daya yang dibutuhkan untuk proses pendampingan (*proctoring*) tersebut.

BAB V

ETIK DAN DISIPLIN

A. Konsep

1. Setiap staf medis dalam melaksanakan asuhan medis di rumah sakit harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme kedokteran kinerja profesional yang baik sehingga dapat memperlihatkan kinerja profesi yang baik. Dengan kinerja profesional yang baik tersebut pasien akan memperoleh asuhan medis yang aman dan efektif.
2. Upaya peningkatan profesionalisme staf medis dilakukan dengan melaksanakan program pembinaan profesionalisme kedokteran dan upaya pendisiplinan berperilaku profesional staf medis di lingkungan rumah sakit.
3. Dalam penanganan asuhan medis tidak jarang dijumpai kesulitan dalam pengambilan keputusan etis sehingga diperlukan adanya suatu unit kerja yang dapat membantu memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis tersebut.
4. Pelaksanaan keputusan subkomite etika dan disiplin profesi di rumah sakit merupakan upaya pendisiplinan oleh komite medik terhadap staf medis di rumah sakit yang bersangkutan sehingga pelaksanaan dan keputusan ini tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan proses penegakan disiplin profesi kedokteran di lembaga pemerintah, penegakan etika medis di organisasi profesi, maupun penegakan hukum.
5. Pengaturan dan penerapan penegakan disiplin profesi bukanlah sebuah penegakan disiplin kepegawaian yang diatur dalam tata tertib kepegawaian pada umumnya. Subkomite ini memiliki semangat yang berlandaskan, antara lain:
 - a. Peraturan internal rumah sakit
 - b. Peraturan internal staf medis
 - c. Etik rumah sakit
 - d. Norma etika medis dan norma-norma bioetika
6. Tolok ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional staf medis, antara lain:
 - a. Pedoman pelayanan kedokteran di rumah sakit
 - b. Prosedur kerja pelayanan di rumah sakit
 - c. Daftar kewenangan klinis di rumah sakit
 - d. Pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis (*white paper*) di rumah sakit
 - e. Kode etik kedokteran Indonesia
 - f. Pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik)
 - g. Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia
 - h. Pedoman pelayanan medik/klinik
 - i. Standar prosedur operasional asuhan medis.

B. Keanggotaan.

Subkomite etika dan disiplin profesi di RS Prima Husada terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis (*Clinical Appointment*) di rumah sakit tersebut dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Pengorganisasian subkomite etika dan disiplin profesi sekurang-kurangnya terdiri dari

ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik.

C. Tujuan

Tujuan dibentuk subkomite etika dan disiplin :

1. Melindungi pasien dari pelayanan staf medis yang tidak memenuhi syarat (*unqualified*) dan tidak layak (*unfit/unproper*) untuk melakukan asuhan klinis (*clinical care*)
2. Memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme staf medis di rumah sakit.

D. Mekanisme Kerja

Kepala rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur seluruh mekanisme kerja subkomite disiplin dan etika profesi berdasarkan masukan komite medis. Selain itu Kepala rumah sakit bertanggung jawab atas tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara.

Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh ketua subkomite etika dan disiplin profesi. Panel terdiri 3 (tiga) orang staf medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang dari subkomite etik dan disiplin profesi yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa
2. 2 (dua) orang atau lebih staf medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar rumah sakit, baik atas permintaan komite medik dengan persetujuan Kepala rumah sakit atau Kepala rumah sakit melaporkan.

Panel tersebut dapat juga melibatkan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit. Pengikutsertaan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh rumah sakit berdasarkan rekomendasi komite medik.

1. Upaya Pendisiplinan Perilaku Profesional

Mekanisme pemeriksaan pada upaya pendisiplinan perilaku profesional adalah sebagai berikut berdasarkan sumber laporan dari :

- a. Notifikasi (laporan) yang berasal dari perorangan, antara lain:
 - 1) Manajemen rumah sakit
 - 2) Staf medis lain
 - 3) Tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan
 - 4) Pasien atau keluarga pasien.
- b. Notifikasi (laporan) yang berasal dari non perorangan berasal dari:
 - 1) Hasil konferensi kematian
 - 2) Hasil konferensi klinis.

2. Dasar Dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi. Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi oleh seorang staf medis adalah hal-hal yang menyangkut, antara lain:

- a. Kompetensi klinis
- b. Penatalaksanaan kasus medis
- c. Pelanggaran disiplin profesi

-
- d. Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit
 - e. Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien.
3. Pemeriksaan
- a. Dilakukan oleh panel pendisiplinan profesiMelalui proses pembuktia
 - b. Dicatat oleh petugas sekretariat komite medik
 - c. Terlapor dapat didampingi oleh personil dari rumah sakit tersebut
 - d. Panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan
 - e. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel disiplin profesi bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia.
4. Keputusan
- Keputusan panel yang dibentuk oleh subkomite etika dan disiplin profesi diambil berdasarkan suara terbanyak, untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran disiplin profesi kedokteran di rumah sakit. Bilamana terlapor merasa keberatan dengan keputusan panel, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya dengan memberikan bukti baru kepada subkomite etika dan disiplin yang kemudian akan membentuk panel baru. Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan kepada direksi rumah sakit melalui komite medik.
5. Tindakan Pendisiplinan Perilaku Profesional. Rekomendasi pemberian tindakan pendisiplinan profesi pada staf medis oleh subkomite etika dan disiplin profesi di rumah sakit berupa:
- a. Peringatan tertulis
 - b. Limitasi (reduksi) kewenangan klinis (*clinical privilege*)
 - c. Bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut
 - d. Pencabutan kewenangan klinis (*clinical privilege*) sementara atau selamanya.
 - e. Pelaksanaan Keputusan. Keputusan subkomite etika dan disiplin profesi tentang pemberian tindakan disiplin profesi diserahkan kepada Kepala rumah sakit oleh ketua komite medik sebagai rekomendasi, selanjutnya Kepala rumah sakit melakukan eksekusi.
6. Pembinaan Profesionalisme Kedokteran
- Subkomite etika dan disiplin profesi menyusun materi kegiatan pembinaan profesionalisme kedokteran. Pelaksanaan pembinaan profesionalisme kedokteran dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, simposium, lokakarya, dan sebagainya yang dilakukan oleh unit kerja rumah sakit terkait seperti unit pendidikan dan latihan, komite medik, dan sebagainya.
7. Pertimbangan Keputusan Etis
- Staf medis dapat meminta pertimbangan pengambilan keputusan etis pada suatu kasus pengobatan di rumah sakit melalui kelompok profesinya kepada komite medik. Subkomite etika dan disiplin profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etis tersebut.

BAB VI

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (*MEDICAL STAFF BY LAWS*)

A. Pendahuluan

Setiap rumah sakit menyusun peraturan internal staf medis (*Medical Staff By Laws*) untuk mengatur penyelenggaraan profesi medis dan mekanisme kerja komite medik di rumah sakit. Peraturan internal staf medis disusun oleh komite medik dan disahkan oleh kepala/direktur rumah sakit. Paling lama setiap tiga tahun peraturan internal staf medis rumah sakit ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan profesi medis dan kondisi rumah sakit.

Peraturan internal staf medis (*Medical Staff By Laws*) dianalogikan sebagai undang-undang praktik kedokteran bagi para staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut. Di dalam peraturan internal staf medis diatur tentang pembentukan komite medik, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja komite medik beserta ketiga subkomitennya, mitra bestari (*peer-group*), dan mekanisme pengambilan keputusan dalam komite medik.

Peraturan internal staf medis menjadi acuan mekanisme pengambilan keputusan oleh komite medik, dan menjadi dasar hukum yang sah untuk setiap keputusan yang diambil sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan internal staf medis. Selain itu, peraturan internal staf medis juga menjadi dasar hukum yang sah untuk setiap keputusan yang diambil oleh kepala/direktur rumah sakit yang mengambil keputusan sesuai dengan lingkup tugasnya yang terkait dengan staf medis.

Dalam hubungannya dengan direksi rumah sakit, peraturan internal staf medis juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban komite medik kepada kepala/direktur rumah sakit untuk hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan profesionalisme kedokteran di rumah sakit. Selain itu dalam peraturan internal staf medis juga diatur kewajiban kepala rumah sakit untuk menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan oleh komite medik untuk melaksanakan tugasnya, misalnya kebutuhan ruangan, petugas sekretariat, sarana dan prasarana komite medik, termasuk penyelenggaraan pertemuan dan mendatangkan mitra bestari. Kewajiban kepala rumah sakit juga termasuk menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur (*policy and procedures*) yang terkait dengan kredensial, mutu profesi, dan disiplin profesi.

Peraturan internal staf medis tidak mengatur hal-hal yang bersifat pengelolaan rumah sakit, walaupun hal itu menyangkut tugas staf medis sehari-hari di rumah sakit. Hal-hal yang termasuk pengelolaan rumah sakit tersebut antara lain hal-hal yang menyangkut jasa medis, pembelian alat-alat medis, pengaturan jadwal jaga, dan sebagainya. Demikian pula, peraturan internal staf medis tidak mengatur hak dan kewajiban para staf medis seperti misalnya pengaturan tentang rekam medis, rahasia kedokteran, persetujuan pelayanan medis, dan kesejahteraan para staf medis. Walaupun beberapa segi yang menyangkut kesejahteraan para staf medis sangat penting diperhatikan oleh kepala/direktur rumah sakit agar para staf medis dapat melakukan tugasnya dengan baik, namun masalah kesejahteraan tersebut tidak termasuk dalam tugas komite medik.

Peraturan internal staf medis dapat berbeda untuk setiap rumah sakit, karena situasi dan kondisi setiap rumah sakit pun berbeda (*hospital specific*) sesuai dengan sumber

daya dan lingkup pelayanannya. Namun demikian, pada dasarnya peraturan internal staf medis memuat pengaturan pokok untuk menegakkan profesionalisme tenaga dengan mengatur mekanisme pemberian izin melakukan pelayanan medis (*entering to the profession*), mekanisme mempertahankan profesionalisme (*maintaining professionalism*), dan mekanisme pendisiplinan (*expelling from the profession*). Peraturan internal staf medis juga mengatur tugas spesifik dari subkomite kredensial, subkomite mutu profesi, dan subkomite etika dan disiplin profesi sesuai dengan kondisi setiap rumah sakit.

B. Format Dan Substansi Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf By Laws*).

Format peraturan internal staf medis (*Medical Staff By Laws*) disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap rumah sakit (*tailor made*). Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang disusun sesederhana dan ringkas mungkin agar mudah dimengerti. Penomoran dan pengaturan bab serta rumusan pasal-pasal nya disesuaikan dengan situasi setempat.

C. Pelayanan DPJP

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelayanan DPJP sesuai dengan Peraturan Direktur Prima Husada tentang Nomor 117/I-PER/DIR/I/2018 tentang Panduan DPJP adalah sebagai berikut :

1. Setiap pasien harus dikelola oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) untuk memberikan asuhan kepada pasien.
2. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang bertanggung jawab melakukan koordinasi asuhan dan bertugas dalam seluruh fase asuhan rawat inap pasien serta teridentifikasi dalam rekam medis pasien.
3. Proses pengaturan perpindahan tanggung jawab koordinasi asuhan pasien dari satu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) ke DPJP lain, termasuk bila terjadi perubahan DPJP Utama.
4. DPJP yang ditetapkan telah memenuhi proses kredensial yang sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Bila dilaksanakan rawat bersama ditetapkan DPJP Utama sebagai koordinator asuhan pasien.
6. Ringkasan pasien pulang dibuat sebelum pasien keluar dari rumah sakit oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP).
7. Satu salinan ringkasan diberikan kepada pasien dan bila diperlukan dapat diserahkan kepada tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan kelanjutan asuhan.
8. Satu salinan ringkasan yang lengkap ditempatkan di rekam medis pasien.
9. Satu salinan ringkasan diberikan kepada pihak penjamin pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit.
10. Informasi penting yang dimasukkan ke dalam PRMRJ diidentifikasi oleh DPJP.
11. Proses tersebut dievaluasi untuk memenuhi kebutuhan para DPJP dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien.
12. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) memberitahu pada pasien atau keluarga tentang informasi kondisi pasien di setiap terjadi perubahan.
13. DPJP, PPJA, dan PPA lainnya harus memperkenalkan diri saat pertama kali bertemu pasien
14. DPJP menjelaskan informasi tindakan (*informed consent*) yang akan diambil dan bila perlu dapat dibantu staf terlatih
15. Sebelum dilakukan pemberian darah harus ada penjelasan dari DPJPnya dan persetujuan dari pasien atau keluarga.

16. Asesmen ulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya untuk evaluasi respons pasien terhadap asuhan yang diberikan sebagai tindak lanjut.
17. Pelaksanaan asesmen ulang medis dilaksanakan minimal satu kali sehari, termasuk akhir minggu / libur untuk pasien akut.
18. Hasil asesmen dan rencana asuhan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya, dokter penanggung jawab pemberi pelayanan (DPJP) mengintegrasikan rencana asuhan dan tindak lanjutnya.
19. Asuhan untuk setiap pasien direncanakan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat, dan PPA lainnya dalam waktu 24 jam sesudah pasien masuk rawat inap.
20. Rencana asuhan dibuat untuk setiap pasien dan dicatat oleh PPA yang memberikan asuhan di rekam medis pasien.
21. Rencana asuhan pasien terintegrasi dibuat dengan sasaran berdasar atas data asesmen awal dan kebutuhan pasien.
22. Rencana asuhan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi pasien, dimutakhirkan, atau direvisi oleh tim PPA berdasar atas asesmen ulang.
23. Perkembangan tiap pasien dievaluasi berkala dan dibuat notasi pada CPPT oleh DPJP sesuai dengan kebutuhan dan diverifikasi harian oleh DPJP.
24. Diagnosis praoperasi dan rencana operasi dicatat di rekam medik pasien oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebelum operasi dimulai.
25. Hasil asesmen yang digunakan untuk menentukan rencana operasi dicatat oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) di rekam medis pasien sebelum operasi dimulai.
26. Edukasi dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan dicatat pada bagian pemberian informasi dalam form persetujuan tindakan kedokteran.
27. Edukasi dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan dicatat pada bagian pemberian informasi dalam form persetujuan tindakan kedokteran
28. Rencana asuhan pascaoperasi dibuat oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat, dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya untuk memenuhi kebutuhan segera pasien pascaoperasi.
29. Rencana asuhan pascaoperasi dicatat di rekam medis pasien dalam waktu 24 jam oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) atau diverifikasi oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) bila ditulis oleh dokter bedah yg didelegasikan.
30. Rencana asuhan pascaoperasi termasuk rencana asuhan medis, keperawatan, dan PPA lainnya berdasar atas kebutuhan pasien.
31. Rencana asuhan pascaoperasi diubah berdasar atas asesmen ulang pasien
32. Proses penerimaan, kredensial, penilaian kinerja, dan rekredensial staf medis diatur dalam peraturan internal staf medis (*medical staff medis by laws*).
33. Setiap dokter yang memberikan pelayanan di rumah sakit wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan regulasi rumah sakit.
34. Proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis oleh rumah sakit untuk pelayanan diagnostik, konsultasi, dan tata laksana yang diberikan oleh dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit seperti kedokteran jarak jauh (*telemedicine*), radiologi jarak jauh (*teleradiology*), dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostik lain: elektrokardiogram (EKG), elektroensefalogram (EEG), elektromiogram (EMG), serta pemeriksaan lain yang serupa.
35. Untuk kepentingan klaim BPJS dan asuransi, DPJP yang praktek di instalasi rawat jalan hanya diperbolehkan merubah jadwal praktek hanya 2 kali dalam setahun dalam jangka waktu 6 bulan sekali

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Buku Pedoman Komite Medik yang telah kami susun. Diharapkan dukungan, kerjasama serta partisipasi dari semua pihak yang terkait. Semoga buku Pedoman ini dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 07 April 2026
PLT Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M.Kes